

EPIESCLERITIS / ESCLERITIS

Álvaro Rodríguez Castelblanco, Marta Cuesta Lasso, Carlos Plaza Laguardia.

La esclera constituye la capa más externa y más gruesa del globo ocular, es parte importante de su arquitectura aportando rigidez por su riqueza en fibras de colágeno. La capa más superficial de la esclera se denomina epiesclera y tiene por función facilitar el deslizamiento del globo ocular con las estructuras aledañas.

EPIESCLERITIS

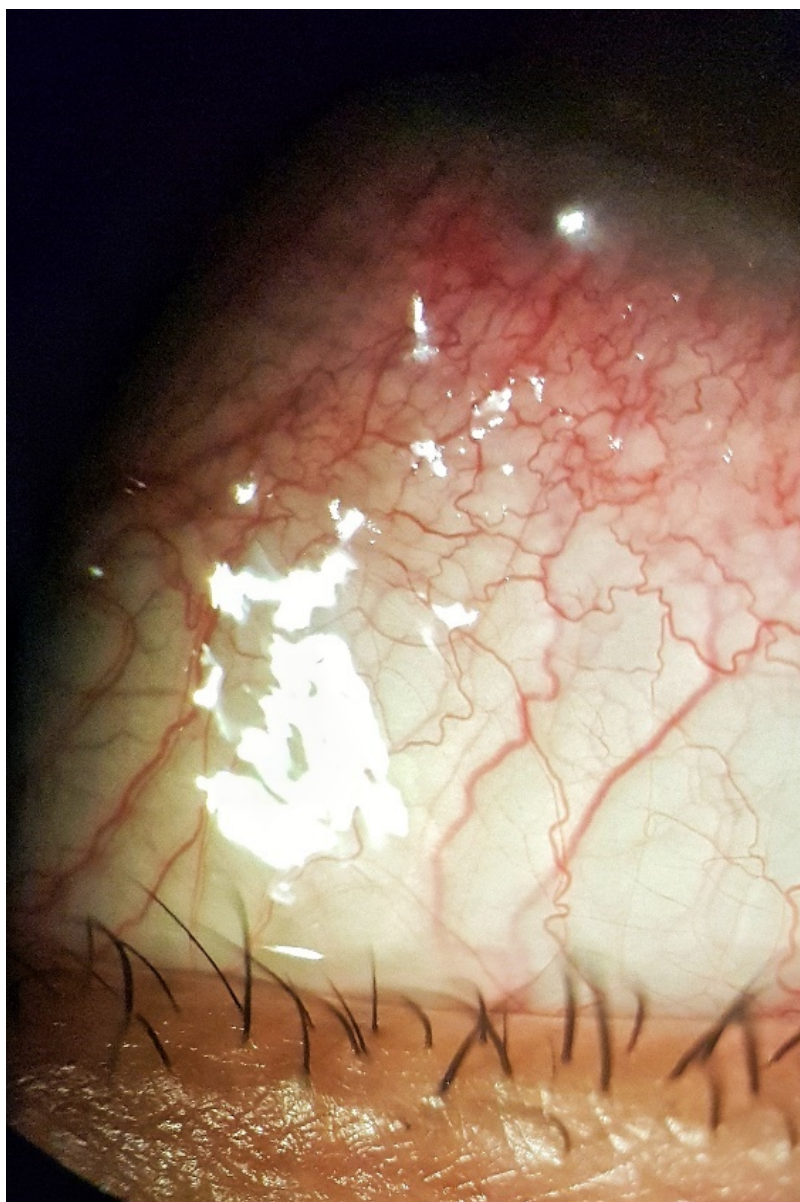
Introducción

El proceso inflamatorio que afecta a la epiesclera se denomina epiescleritis. Es un trastorno frecuente, benigno, de inicio súbito, que cursa en brotes, suele ser autolimitado y afectar a adultos jóvenes mayoritariamente mujeres. Se presenta de forma unilateral, asintomática o con dolor leve, pudiendo asociar lagrimeo y/o fotofobia. Puede recurrir en el 60% de los pacientes. La causa suele ser desconocida, sin embargo, en un tercio de los casos puede existir una enfermedad local o sistémica asociada de origen metabólico (hiperuricemia), inflamatorio (colagenopatías, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Behçet, etc.) o infeccioso (tuberculosis, herpes, etc.).

Diagnóstico

Debemos pensar en este cuadro ante un adulto joven con ojo rojo sectorial de inicio súbito, con visión conservada y sin gran presencia de síntomas. Al examen físico tendremos dos formas de presentación:

- Difusa / simple: La más frecuente, enrojecimiento sectorial de una parte del ojo por inflamación de los vasos epiesclerales (más grandes que los conjuntivales y con trayecto radial por debajo de ellos) que puede ser asintomático o levemente doloroso.



Paciente con diagnóstico de epiescleritis. Se aprecia ingurgitación localizada de vasos episclerales (radiales) con trayecto tortuoso de los mismos a nivel infero nasal de un ojo izquierdo.

- Nodular: Afección focalizada en forma de nódulo, con enrojecimiento aledaño, móvil y doloroso a la palpación. Esta forma de epiescleritis es la que puede asociarse a otras enfermedades, tardando más tiempo en resolverse.

Tratamiento

El pronóstico es benigno incluso sin tratamiento, que estará orientado a aliviar síntomas y mejorar la apariencia de la esclera. En general se usan antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y/o corticoides tópicos y/o lágrimas artificiales. Los casos que no respondan adecuadamente y las formas nodulares, precisarán AINEs orales y derivación al oftalmólogo.

NO OLVIDAR

- Paciente relativamente joven con OJO ROJO LOCALIZADO de aparición espontánea y sin muchos síntomas que blanquea con una gota de fenilefrina: Epiescleritis hasta demostrar lo contrario.

- La gran mayoría de los cuadros son autolimitados e idiopáticos: Tranquilizar al paciente.
- Si presenta una forma nodular: anamnesis dirigida a otras enfermedades que pudieran estar asociadas.
- Manejo inicial:
 - Diclofenaco en colirio 1 gota cada 8 horas por 3 días y/o Fluorometolona (FML®) 3-4 veces al día por 2-4 días y reducir en pauta descendente.
 - De no mejorar: AINE oral y derivación.

ESCLERITIS

Introducción

La escleritis o inflamación de la esclera es una patología poco usual donde subyace un proceso de mediación inmunitaria o infecciosa que causa infiltración celular, ruptura del colágeno y remodelación de vasos sanguíneos. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre los 40 y los 65 años de edad. Se asocia a enfermedades sistémicas en 2/3 de los casos siendo las conectivopatías (artritis reumatoide (AR), lupus eritematoso sistémico y vasculitis) las más frecuentes. Puede también asociarse a enfermedades metabólicas, infecciosas o incluso procesos locales como el herpes zóster. En la mitad de los casos están afectados ambos ojos.

Diagnóstico

Dependiendo del sitio primario de inflamación se pueden dividir en:

- **Escleritis anterior:** Constituyen prácticamente la totalidad de los casos de escleritis. A grandes rasgos es similar a la epiescleritis pero la intensidad de síntomas es mayor, sobre todo el dolor ocular que en estos casos es intenso y a veces irradiado, pudiendo asociarse a disminución de la agudeza visual. La inflamación de los vasos esclerales puede hacer que aparezca una tonalidad violácea que se aprecia mejor con luz ambiente. Se subdivide en:
 - **No necrotizante** (más de 80% de los casos de escleritis)
 - Difusa: Ojo rojo sectorial o afectando toda la esclera anterior.



Paciente con escleritis anterior difusa. La dilatación de vasos sanguíneos involucra la epiesclera y también los vasos esclerales (más borrosos, se aprecian parches rosas en la fotografía dada su mayor profundidad), se trata de un paciente que acudió a urgencias con ojo rojo e intenso dolor.

- Nodular: Nódulo rojo violáceo con centro amarillento, inmóvil a diferencia de la epiescleritis.
- **Necrotizante** (14% de los casos)
 - Con inflamación: Formas más graves y destructivas. Dolor intenso, adelgazamiento de la esclera que se vuelve transparente incluso llegando a exponerse la úvea, adquiriendo una coloración grisácea y eventual alteración importante de la agudeza visual. Presenta una fuerte asociación a vasculitis sistémica potencialmente mortal.
 - Sin inflamación (Escleromalacia perforante): Es una forma típica en pacientes (la mayoría mujeres) con AR de larga evolución. Presenta un intenso adelgazamiento escleral pero habitualmente es asintomática.



Escleromalacia perforante: Paciente con AR de larga evolución muestra zonas parcheadas de adelgazamiento escleral en su ojo izquierdo que trasluce parte de la coroides adquiriendo una coloración grisácea – violácea.

- **Escleritis posterior** (2% de los casos): Mínimo dolor, hiperemia y pérdida de agudeza visual. La sospecha y manejo es por parte del oftalmólogo.

Tratamiento

El manejo definitivo debe ser realizado por un oftalmólogo. Ante una clara sospecha, y previo a la derivación, se puede iniciar tratamiento con AINEs y corticoides tópicos (ver epiescleritis).

No olvidar

- Ante la sospecha de escleritis:
 - Anamnesis dirigida en busca de enfermedades sistémicas. La escleritis puede ser el debut de la enfermedad de base y/o indicar un mal control de la misma.
 - Derivación a oftalmología.
- Diagnóstico diferencial entre epiescleritis y escleritis:

	Epiescleritis	Escleritis
<i>Ojo rojo debido a...</i>	Vasodilatación del plexo epiescleral superficial y conjuntival	Afectación de todos los plexos vasculares (sobre todo el profundo)
<i>Características del ojo rojo</i>	Rosado o rojo brillante	Violáceo a la luz ambiente
<i>Al aplicar fenilefrina...</i>	Blanquea	No blanquea

	Epiescleritis	Escleritis
Causa	Generalmente idiopática	Casi 2/3 con patología asociada
Síntomas	Leve dolor y molestia	Dolor intenso e irradiado
Alteración de agudeza visual	No	Habitualmente sí
Daño estructural	No	Sí (esclera, córnea o úvea)

BIBLIOGRAFÍA

- Sáinz de la Maza M, Molina N, González-González L. Clinical characteristics of a large cohort of patients with scleritis and episcleritis. *Ophthalmology*, 2012; 119(19): 43-50.
- Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (2014). Escleritis y Epiescleritis. Valencia, España: Fundación FISABIO. Recuperado de: <http://fisabio.san.gva.es/en/escleritis-y-epiescleritis>
- Gerstenblith A, Rabinowitz M. Manual de oftalmología del Wills Eye Institute. 6ta Edición. Cap. 5: Enfermedades de la conjuntiva / esclerótica / iris / anexos (p. 121). Philadelphia, Estados Unidos: Editorial Wolters Kluwer, 2012.